

닭발이나 염소같은 동물정보약제를 쓰는 법

평소 고기를 잘 먹어요 물어봐서 잘 먹는다고 하면 그닥 정증이 아니야

고기를 평소 잘 안먹는다고 하거나 고기를 좋아하지만 돈이 없어 못먹는다고나 어쨌든 평소 고기를 안먹은 사람이어야 해

그다음이 피육이 얇아야 해. 그리고 건조해야 해

당연히 뼈의 퇴행성 변화가 있어서 골극이 잡히거나 무릎이 0자형이 진행되거나 손가락의 뼈마디가 툭툭 볼거져야지

그리고 설진상 혀가 설담백하면서 태가 없거나 갈라졌거나, 설의 크기가 작으면 더욱좋아 내경우는 체질에 맞추어야 하니까 소음인한테 쓰는데

예를 들어 후세방쓸때도 약의 구성이 소음인 약제가 많으면 굳이 비싼 녹용보다 닭발을 쥘봐

소음인약이 보면 가장 취약한것이 뭐냐 하면

보기약과 보양약으로 구성이 되어서 녹용같이 보양과 보혈이 즉 음양이 다 조화된 강력한 보약이 없어 그래서 소음인의 보혈약인 당귀,작약 정도로는 고령의 노약자나 매우 쇠약한 음양兩虛환자에게 쓸 약이 없는 거야

그래서 이때 값싸게 쓸수 있는 약이 닭발이지.

약맛도 부드러워지고

특히 소음인중에 위기허 환자인 경우 인삼이 안맞아 .

그래서 인삼을 빼면 약에 힘이 없어져. 인삼을 넣으면 속이 더 불편해.....?????????

원래 인삼이 보기약이지 보위약은 아니거든.나는 보통 한제에 250G 정도 전자한다.먼저 한시간 달인다고.

[권재식] [오후 6:19] 칠성시장에서 사.

[권재식] [오후 6:19] 그래서 어제 같은 경우 돼지 족발을 고아서 팩으로 만들어 냉동실에 넣어두었지.돼지족발은 자주 쓰니까 한꺼번에 고아서 팩으로 나누어 쓰고 닭발은 그렇게 자주 쓰지 않으니까 생닭발을 사서 냉동실에 얼려두었다가 필요할때 전자한다.그러니까 무조건 보약에 녹용만 넣는다는 공식을 없애면 약값을 절약할수 있다.

또 소양인이나 소음인이 보약이어달래는데 녹용을 넣기가 찝찝하잖아 그런데 지금은 당당하다.내가 사서 쓰면 훨씬 저렴한데 굳이 제품화된것을 뭐하러 쓰냐

아니 22만원이나 25만원정도

그리고 기본 2,3제는 먹어야 하니까 너무 비싸면 안되

그래서 흑염소를 최근에 많이 썼는데 이제는 이게 올라서 녹용값이나 비슷해....된장 흑염소는 녹용과 조금 다르다

이게 흑염소는 귀경이 위장비장같은 소화계통으로 가.녹용은 귀경이 신과 폐잖아.그래서 비기허쪽의 문제가 오면 녹용 대신에 흑염소를 쓰는 거냐...민간에서도 위장이 나쁜허약자에 흑염소를 많이 쓴다

똑같아 전자하는 거나

먼저 달이면 되.....

칠성시장가면 흑염소 파는 데가 있어.. 5년전에는 뼈를 직접 구해서 고았는데....뼈구하기가 너무 어려워 그래서 지금은 살코기 위주로 한다.

그래서 우리가 보약하면 무조건 녹용만 생각하면 앞으로 점점 어려워질것 같아

[권재식] [오후 6:35] 기름이 들어가야지...기름.....기름은 역시 동물성 기름이 최고야
식물성 기름은 몸을 정화시키기 위한 것이지...몸을 기름지게 하지는 못해

예를 들면 토사자보양탕+저골250g

백출건비탕에 +계축 250G

의이인건비탕+산양250G

이게 있잖아 오미자를 증하는것 하고 오미자 생으로 쓰는것하고 차이가 오미자를 쓸 사람
이나 아니냐를 구분하는것보다 중요하지가 않더라 말이지

가능하면 숙지황 들어갈대는 답발 넣지 말고....니가 봐서 소음인약이다 싶을때 넣어라

아교는 당나귀 아교를 꼭 쓰야 한다.

노새아교는 안되고,,,,요즘은 늙은 소가죽아교도 섞인다.

모르면 옴니허브 쓰면 되

우리나라는 참나무가 많아서 대부분 곡기생지

관절염에 기본으로 쓰지않나

속단+곡기생 = 퇴행성 관절염

우슬+오가피/ 속단+곡기생/두충+보골지

[척추전방전위환자 약으로만 많은 호전.난생처음이다...

협착증은 간혹 약만으로 되는데 전방전위는 처음

1차약-산수유 복령 토사자4 숙지황,복분자,구자,선모, 홍모오가피 ,목단피,대계2

2차약-상동(-선모)+택사2 +저골250g

2제먹고 70%호전

59세 여자. 주증. 만성천식으로 기침,황담,백담, 인후매핵기.

누웠을때 기침 심. 밤에 기침심. 가래소리 들림.

만성천식 20년. 천식약 복용중

1차-백자인,맥문동4 천문동,오미자,황금,울금,부소맥,우각2(호전이나 부기여전,다한여전)

2차-수한범폐-행인,길경3 마황3 오미자,황금,관동화,맥문동,나복자,녹각교2(무반응)

3차-한담저폐-의이인,산약4 길경,나복자,생인,오미자2 마황1 관동화,백과2(무반응)--

4차-폐음허-맥문동6 천문동,백합3 길경,황금,사삼,오미자2 행인2(-췌호전)

5차 4차약과 동일 -무반응- 환자가 지쳐서 그만하자함

6차-백부근,길경4 행인,상백피3 포공영,자완,절패모,노근,삼백초2(good)-전화가 먼저옴. 양
약안먹고 현재 괜찮다고 함.

담열옹폐

태양인 2명 오랜만에 안타 한번 쳤다

중년 여자.

주증 이원성 현훈증. 이명동반

변증: 腎比陽虛

처방: 당삼4 파극천, 음양곽3 회우슬,동충하초,영지,홍국2

경과 3제먹고 현훈 많이 호전. 이명조금호전 환자는 현훈만 좋아저도 만족해함.

중년여자.감기 7일 기침(검은가래,푸르스름가래). 야간에 덜하고 낮에 심. 인후통(구미여상, 콧물없음,신열없음)

향유4 잠사,곽향,양충피,시체,송자3 오가피,모과2

3일분먹고 완치

참고로 양충피는 양파의 가장 바깥쪽얇은 껍질. 시체는 감꼭지.... 송자는 배추씨

두분다 내가 과거에 **소음인,태음인,소양인으로 처방해서 다 실패**했다가 태양인으로 해서 치료를 종료했던 환자라 태양인은 확정적일 거야....

하지불안 증후군하고 척추관 협착증, 척추전방전위는 감별이 좀 있는데

척추협착증과 전방전위도 야간에 다리 저림이 있어...

그런데 이게 하지불안증후군하고 다른것이 일단 편측성이야.

척추의 문제로 다리저린것은 편측성이 많아.

간혹 양측성이 있지만 환자가 딱 자리를 지정해줘....담경이던 방광경이든...

특히 척추전방전위는 좌골결절쪽에 특징적으로 통증을 호소하면서 하지저림을 이야기해

그런데 하지불안증후군은 일단 낮에는 정말 멀쩡해.

밤에만 통증,저림...증상이 나타나는데 일단 양측성이고,,,아픈 부위를 지정을 못해....다리 전체가 아프다고 해

그리고 척추를 망진을 해보면 ,,,,이학적검사를 해보면 딱히 척추에 문제가 없어

협착증은 양측으로 오니까 편측, 양측~은 정확한 구분 포인트는 아니고

사실 이게 옛날에는 다 디스크나 협착증, 좌골신경통으로 해석해서 치료하던 부분인데

[정지영] [오후 12:54] 검사를 하면 명확하게 디스크라고 진단할만하지 않은데서 다른 병명이 붙여진거고 구지 구분을 짓자면 낮에 활동할때는 괜찮다가 저녁에 일정시간을 넘기면 갑자기 증상이 발현된다는거라 한쪽다리로 증상이 있을 경우도 디스크 판정을 내릴만한 소견이 없으면 증후군으로 이름 붙이는거지

그중에 낮에도 심하면 좌골신경통~으로 예전에는 많이 썼고

밤에만 증상이 나타날 경우 **예전에 좌골신경통으로 진단한 거를 야간하지불안증~으로** 떠낸 거라

최근에 붙인 이름들이니까

양방에서는 신경학적 소견이 없으니까 대체로 혈액순환이상으로 보는거 같고

[권재식] [오후 7:11] 34세.여자인데 흰피부에 마른체형,

[권재식] [오후 7:11] 캐나다에 사는 교포인데 **증상은 하지불안증후군.**

[권재식] [오후 7:11] **피로가 심하고, 야간에 다리가 저려서 잠을 못잠..식욕감소심, 복부 팽,복명감. 생리불규칙**

[권재식] [오후 7:13] 비기허>혈허

[권재식] [오후 7:14] 처방: 중국백출4g 구감초,대조3g

[권재식] [오후 7:14] 백작약초,생강,참쌀,계내금,진피2g 20첩+ 닭발250g

[권재식] [오후 7:18] 44세마른체형여. 주증 아프타성구내염, 또는 베체트씨병 둘중에 하나인데 일단 구창,인후창빈발

[권재식] [오후 7:18] 3년전에 류마티스 진단나왔음

[권재식] [오후 7:19] 잠을 자도 계속 피로가 심. 두통, 구미감소

[권재식] [오후 7:20] 산약초,건율6g 용안육4g 의이인초,나복자초,오미자증2g 녹각교3g 유근피,삼백초2g

[권재식] [오후 5:41] 50세 여자환자가 왔는데 체형은 약간 통통한 스타일. 보통체형에서 약간 통통.

[권재식] [오후 5:41] 주증: 구미퇴, 구고,오폭,두중통,

[권재식] [오후 5:42] 현병력:5일전 신열,인후통으로 양약을 5일간먹고 상기주증발생. 양약은 5알을 하루 3번.

[권재식] [오후 5:42] 주증다시:구미퇴,발한,무기력,구고,오폭,두중통

[권재식] [오후 5:44] 설태: 태백후, 맥소양인맥. 27맥으로 완무력맥.

[권재식] [오후 5:44] 변증: 상한 소양증

[권재식] [오후 5:45] 치법: 보비위, 겸 해기

[권재식] [오후 5:45] 처방: 상한방-소시호탕

[권재식] [오후 5:45] 후세방-향사양위탕+ 황기증량,방풍

[권재식] [오후 5:46] 후세방-보중익기탕춘방

[권재식] [오후 5:46] 과거사상방-형방지황탕

[권재식] [오후 5:47] 나의 처방- 홍맥건비탕+ 방풍,전호

[권재식] [오후 5:47] 참 각양각색이지.....내가 봐도 어느것이 정답이라고 말하기는 그래

[권재식] [오후 5:47] 처방이라는 것은 완전히 100%짜리는 없는것 같애

[권재식] [오후 6:41] 토창출이 참 좋은 약인것같아.

[권재식] [오후 6:41] 안그러면 소양인에 건비조습하는 약이 없잖아

[권재식] [오후 6:42] 거기다가 해표기능도 있고

[권재식] [오후 6:42] 또 기울에도 작용하고

[권재식] [오후 6:45] 중국창출이 소음인것이고, 토창출은 소양인.

[권재식] [오후 6:45] 둘은 완전히 종이 다른 식물이다.

[권재식] [오후 6:51] 백출 창출 구분은 의미가 없어

[권재식] [오후 6:52] 어차피 한뿌리에서 나오는 것인데 뭐

[서성훈] [오후 6:55] 토창출이 그러니 삼주뿌리 2-3년생이잖아 그게소양인약이라 이말인데 삼주 1년생은 그러면 백출인디 이거는 소음인약이다?아니면 따로 백출이있다는거여?

[권재식] [오후 6:56] 아니 그뜻이 아니고

우리나라 즉 남한에서 자라는 아니면 재배하는 창출의 종과 중국과 북한에서 들어오는 창출은 식물종이 다른 것이라고

다시 말하면 배추와 양배추가 같은 배추지만 전혀 다른 종이라는 말이다

W[권재식] [오후 7:34] 얼마전에 의이인이 군약인 처방을 하나 썼다

[권재식] [오후 7:34] 의이인,유근피,,,,뭐 이렇게 나가는 건데

[권재식] [오후 7:34] 예전에 이약을 먹고 식도염이 매우 좋았던 환자거든

[권재식] [오후 7:35] 그런데 이번에 약먹고 5일뒤에 전화와서 변비가 생겼데

[권재식] [오후 7:35] 틀림없는 태음인에 간기범위 환자야

[권재식] [오후 7:35] 이경우에 내가 어떻게 했냐하면 의이인을 빼고, 노근을 넣었어 군약으로 그러니까 변비 해결, 식도염 해결,,,모든게 해결

[권재식] [오후 7:37] 이환자는 분명히 한증의 간기범위환자가 맞아

[권재식] [오후 7:37] 그런데 예전에는 들었는데 이번에는 변비가 생겼다는 것은 이사람의 한열에 변동이 생긴것을 말한것이야

원래 음한지기가 강한 음장인이야.그런데 스트레스로 내열이 겹했다 말이야

한자가 열자가 된것이 아니고 한자인데 열증이 낀것이야

그러면 처방중에 한개를 빼고 한개를 넣어야해

뭘 뺄것인가....당연히 의이인을 빼야지

그러면 다음에 뭘 넣을 것인가

청위열하는 약을 선택을 해야잖아

태음인 청위열이 뭐가 있어,,,

황금,대황, 황정,사삼이 있는데

여기서 황금,대황은 약성이 너무 강해서 제외

황정,사삼은 위음허 약이지 청위열약은 아니야

그러면 노근이 남잖아. 그리고 노근의 귀경이 폐열과 위열을 내리잖아

그러면 폐열이라는 것은 병의 표리상 식도꼭지잖아,????????????????????????????????

그러면 가장 적합한 약재가 노근이지

[서성훈] [오후 7:41] 그러면 석고를 버린 이유는?

[권재식] [오후 7:41] 태음인이라니까

[서성훈] [오후 7:42] 노근이 태음인약인 근거는?

[권재식] [오후 7:42] 사상방을 하면 약물을 버릴수 있는 근거가 많아져. 그래서 약이 간명해지는거야

[권재식] [오후 7:42] 내가 먹어봤거든.....아주 적극적으로 하루에 6봉지씩 6일간

[권재식] [오후 7:42] 태음인약이야,, 태양인약이 아니야

[권재식] [오후 7:43] 귀납적인 연구방법인데 이것 이상 더 좋은 방법있으면 나와보라고 해...

[권재식] [오후 7:43] 먹어보고 판단한다는데할말없잖아...

[권재식] [오후 7:44] 왜냐하면 군약은 임금이기 때문에 약성이 무난해야해

[권재식] [오후 7:45] 그래서 이경우는 죽여가 가장 적합하지.

[권재식] [오후 7:45] 같은 위열이라고 군약이 될 수 있는 자격이 있고,,군약이 될수 없는 약이 있다

[서성훈] [오후 7:45] 체질맥진 이외에는 체질감별방법이 없는건가?

[권재식] [오후 7:45] 왜 없어 많지

[권재식] [오후 7:46] 수도 없이 많지

[권재식] [오후 7:47] 이런 모든 감별법을 다하면 체질을 맞추는 확률이 점점 높아지면 다 하겠지만

[권재식] [오후 7:47] 1개를 하던 3개를 하던 체질감별의 확률은 어차피 똑같아

[권재식] [오후 7:47] 체질감별은 감별법이 중요한것이 아니라 진단하는 의사의 내공이 중요한것이야

[권재식] [오후 7:49] 우선에 한의원에 가장 많이 오는 환자가 잡병이니까 팔강변증, 장부변증을 위주로 하고,,,나중에 그것에 대해 더 할것이 없으면 외감변증으로 가라...

[권재식] [오후 7:49] 지금은 팔강,장부변증에 집중해야 한다.

[권재식] [오후 7:49] 그리고 본초

본초를 모르면 처방 백날 들여다 봐도 이해가 안되

왜냐하면 본초가 가장 기본이야

우리가 결국 하는 행위는 병을 치료하는 것인데

그 도구가 약이거든.

그런데 약을 구성하는 본초를 모르면 내가 치료하고자 하는 의도와는 전혀 다른 처방을 구사하는 것이지

의이인건비탕은 본초입장에서 방해가 가능하냐?

본초가 다 건비하는 약이잖아.

의인초,건율,산약초, ..

비는 습을 싫어하니까 석창포

오미자는 신맛이 있으니까 구미감소에 당연히 오미자갈 들어가야지

그러면 반대로 위산과다자는 오미자가 들어가면 안되지

용안육은 건비하는 약이잖아

만약에 비기허환자인데 **이사람이 매우 말랐어** 복부를 보니까 기름끼 하나 없어

이런경우 석창포 당연히 빼야지

입맛이 없는 데 복만감 있고, 복부에 물소리가 출렁 출렁 나고,,,설사하고

당연히 석창포 올려야지

석창포는 건비하는 약이 아니고 습을 제거하는 것이라니까

건비의 보조약이지

지부자는 두가지의 의미가 있어. 하나는 이수지제이고, 하나는 보신음허하는 益精强陰하는 효능이 있어

본초를 볼때 한가지의 본초인데 효능이 하나는 허증을 하나는 실증을 말하는 본초가 있어

대표적인것이 적하수오,발계,음양곽

같은 이런 약은 실증효능과 허증효능이 같이있어

그리고 지부자도 마찬가지로이고. 여기서 지부자는
 첫째 의미는 인정의 의미가 있어
 둘째의미는 실제로 지부자의 효능중에 익정강음의 효능이 있어
 여기 까지가 책의 내용이고
 내생각은 지부자의 원 효능은 이수제가 맞아
 육미지황탕에서 택사가 들어가듯이
 만약에 신음허환자인데 소변빈삭,소변불인이라면 당연히 지부자를 빼야겠지
 그런데 신음허환자인데 소변빈삭,소변불리라면 당연히 넣어야지

가벼운것은 감국부터 시작을 해,,,
 그다음은 승마,,,
 그다음은 황금
 그다음은 하고초,청호,괴화
 그다음은 대황
 이런식으로 각각의 열증처방이라도 그 환자의 나이,몸의 상황, 발병기간에 따라 열증약을 나누어서 쓰야해
 그래서열다한소탕 쓰도 비염이 낮고, 형방지황탕 쓰도 비염이 낮는다는 말이 나오는 거지
 열다한소탕은 태음인한테는 열자한테 쓰지만
 형방지황탕은 소양인에게는 한자한테 쓰거든
 다시 말하면 이사람이 태음인이라고 가정했을때 형방지황탕은 변증은 맞는거야.
 왜 태음인에게 형방지황탕은 열증이거든
 그러니까 변증이 맞는거지
 이사람이 소양인 한자라고 가정을 한다면
 형방지황탕이 맞지
 그런데 열다한소탕도 이사람한테는 한자처방이 되는것야
 한열의 체질적인 상대적인 음양론이지
 그런데 이런 비염이 만약 축농증이나 위축성 비염,,,건조성비염으로 가잖아
 체질변증이 딱 떨어지지 않으면 꿈쩍도 않해
 단순 비염이나 알러지비염,,,축농증 가벼운것은 체질 틀려도 변증만 맞아도 되
 그런데 위축성비염 축농증심한것, 건조성비염으로 가면 체질 안맞으면 꿈쩍도 않애
 [서성훈] [오후 7:00] 소양인 한자라 케도 태음인보다는 열자다 이말이고

[권재식] [오후 7:00] 그래서 내가 처음에 말했든 음실양허,양실음허,,,,,이게 가장 기본이 되는 거지
 석고하고 대황하고 붙으면 대황은 석고보다 뜨거운 약이야
 소양인 선모하고 태음인 쇄양하고 붙으면
 선모는 쇄양에 비해 찬약이야
 선모는 쇄양에 비해 찬약이야
 [서성훈] [오후 7:02] 결국은 소양인약이 가장차고 소음인약이 가장뜨겁다 이말이잖아

[권재식] [오후 7:03] 그렇지....이 개념을 알아야 환자가 말하는 부작용을 이해를 하거든

[권재식] [오후 7:03] 옥미지황탕 주었더니 소화가 너무 잘돼요

[권재식] [오후 7:03] 보중익기탕을 먹고 설사를 해요

[권재식] [오후 7:03] 이것 어떻게 해석할거야

[권재식] [오후 7:03] 오래전에 삼출건비탕 주었더니 설사한다고 전화가 와....덴장

[권재식] [오후 7:04] 쓸약이 없어

[권재식] [오후 7:04] 심지어 있잖아 도적산 주었는데...살이쥘데,,,입맛이 너무 돌고

[권재식] [오후 7:09] 문제는 동일한 대증을 우리는 팔강으로 구분을 해야한다는게 문제라

[권재식] [오후 7:10] 같은 설사라도 한증,열증,표증,이증,을 나누어야 하니까

[권재식] [오후 7:11] 한약을 먹으면 환자가 커피보다 맛있다고 해

[권재식] [오후 7:11] 변증이 정확하면 한약을 먹는 시간이 기다려지고 맛이 좋데....

[권재식] [오후 7:12] 너 저번에 경험했잖아.

[권재식] [오후 7:12] 태음인약먹고 입이 뚱뚱했잖아

[권재식] [오후 7:12] 소음인약먹고 속이 쓰리다고 했잖아

[권재식] [오후 7:12] 약을 먹으면 입이 뚱뚱데 계속 나누어서 먹으라고 하면 환자가 기분
이 좋겠냐

교이는 참쌀을 뽕아서 쓰고,,,,홍맥은 없으면 맥아초해서 써. 맥이당은 구할려고 하면 나한
테 전화하면 전화번호 가르켜 줄끼고.

굳이 홍맥,맥이당 없어도 되니까...나중에 진짜로 사상 처방을 많이 쓰면 구해도 되...ㅎㅎ

난임환자인데 약을 줄수록 생리가 더 안좋아져

그래서 환자와 상당한 트라블이 있었는데

마지막 약에 오늘 임신을 했어

처음에 준약이

태음약의 신양허약을 주었는데 생리가 확줄어버려

그래서 소양인신기허약으로 주었다....그러니까 설사가 나고 생리통이 더 심해

그러니까 환자가 더디어 화를 내더라고 나도 너무 미안하고

그래서 내가 그랬지,,,약값을 환불해드릴수도 있고, 정신적인 피해를 원하시면 보험으로 해
드리겠다 그랬더니 남편과 상의를 하고 나서 한번만 더 믿겠데

그러니까 내가 겁이 나는거야...

처방을 고민고민하다가

인삼,사원자(황기씨), 백작약,당귀,두충,감초,아교.....씻지

총 7개.

약을 먹고 보름이 지났는데 전화가 안와

그래서 전화를 했더니 예정일보다 생리가 안나온데

우와 한 7일을 걱정을 했는데,,,알고보니 임신이었는데

어제는 환자가 약을 먹고 두드러기가 더 심해졌다고 욱먹었다.

거제도있는환자인데 약먹기전에는 저녁에만 가려웠는데 약먹고 아침부터 가렵데

거제도라 와서 다시 진맥을 하라고 할수도 없고,,,,이때는 정말 고민이다.

선태,백질려,감국 상업,부평,승마,황금,화피

화피는 산벚나무

사원자는 황기씨이고 충율자는 익모초씨이고

지부자는 태음인. 질려자도 태음인.

인간이 지구상에 만물의 영장이라는 가정하에서 인간이 먹거리로 하고있는 지구에 있는 모든 식물,동물이 모든것이 인간에게 적합하다고는 생각은 안해

그래서 그중에서는 나에게 안맞는 것도 있고, 맞는 것도 있고,,,,,그것을 양방적으로 해석을 하면 알레르기라고 하고

한방적으로 이야기하면 나에게 안맞는 식물, 동물이라고 해석을 하는 거야

그것이 격렬하게 반응이 오면 우리가 두드러기나, 설사, 복통, 호흡곤란,,,,심하면 아낙팔락시스 속이 오겠지

그것을 알려지라고 판단을 양방에서는 하는 거야

그렇다면 약하게 ,,아주 천천히 반응이 오는 것도 있을수 있잖아

그것도 일종의 알려지로 파악을 해야 하는 거야

예를 들면 숙지황을 소음인이 먹으면 설사를 한다면 숙지황이 소음인에게 알려지를 일으킨 것이지 그래서 체질약을 양방적으로 해석을 하면 나에게 알려지를 유발하는 약을 배제하는

학문이지 또, 체질약이라는 것이 양방적으로 해석을 하면 나에게 알려지를 일으키지 않는 약을 선택을 하는 것이지

예를 들어,,,,과거에 천식으로 어린아이가 왔어.....도저히 체질을 모르겠더라고,,,,이것 저것 진맥해도 도저히 체질을 모르겠어

이럴때 마지막 히든카드로 " 혹시 알려지있는 음식이 있어요" 하니 ,,,,

엄마왈.....아주 어릴때 양과먹고 온몸이 두드러기 난적이 있어요 라고 해.

양과=태양인.... 그 단서하나로 태음인약을 써서 낮게 한적 있거든

알러지 유발물질이라는 것이 진짜로 유발하는 경우도 있고, 또 과거의 혼란 경험으로 정신적으로 트라우마로 인해 몸이 반응하는 경우도 있다.

분명히 소양인이 맞는데 돼지고기 먹으면 무조건 두드러기가 생긴다는 환자가 왔어.

내가 이환자에게 한약을 주면서 돼지뼈를 같이 삶아서 주었다.....두드러기 안생기고,,병이 나았어. 나중에 물어보니 아주 어릴때 돼지고기먹고 급체를 했데....그래서 며칠을 혼이난거야. 그 뒤로 돼지고기가 자기에게 안맞다고 아예 안먹었다는 거야.

그래서 알려지 유발물질이라는 것이 진짜 알려지를 유발한다면 그것은 자기 체질이 아닌 것이 확실해.

그런데 자기 체질음식이 맞는데 알려지를 유발한다면 그것은 과거의 트라우마가 있는지 정신적인 충격이 있었는지 확인을 해야할것 같아.

그러면 커피먹으면 잠이 안온다는 태음인은 어떻게 해석을 해야 하느냐. 태음인=커피인데. 두가지 경우가 있어

커피에 섞인 첨가물에 민감하게 반응을 하는 경우가 있고,,,,이경우는 원두커피 먹으면 편안하게 잠을 자.

두번째는 커피가 현재 이 태음인의 병과 안맞는 거야. 팔강적으로든, 장부적으로든...

그래서 산약먹고 배가 아프다면 일단 태음인은 아니라고 보는 것이 맞아. 그건 틀림없어.
왜냐하면 산약은 방약합편에도 나오지만 상통에 있는 아주 성스러운 부드러운 약이야
그래서 웬만큼 까다롭지 않으면 체질틀려도 다 먹어내는 무난한 약이지.
그런데 이것먹고 배아팠다면 일단 태음인은 아니라고 보면 되.....태음인은 산약에 절대 알러
지가 없어.

산약잘먹는다고 태음인이다 는 아니지만 산약먹으면 아프다~라고하면 태음인은 배제

커피는 다먹지만 커피는 못먹는다 그러면 태음인은 아니다?

확실히 그러면 아닌거지

잠을 좀 못자는 정도가 아니고

커피를 조금만 먹으면 밤을 완전히 세는 정도면 태음인은 아니다 말이지

그러니까 지영이는 태음인이 아닌것은 확실한 거지

[권재식] [오후 8:04] 지영이 정도 의 반응이면 알려지가 매우 심한거야

[권재식] [오후 8:04] 이정도 알려지면 태음인은 확실히 배제하는 거야

[권재식] [오후 8:05] 커피먹으면 배아픈 사람도 있다

[권재식] [오후 8:05] 우유먹고 설사는 것은 태음인도 많아

[권재식] [오후 8:05] 하지만 우유먹으면 배아프고 설사하는 것이 확실하면 태음인이 아닌
거지

설사는 아닌데 가스가 많이차지

[권재식] [오후 8:06] 그 정도증상으로는 알려지라고 하면 안되.

[권재식] [오후 8:07] 예를 들어 홍삼먹고 얼굴에 열오르고 가슴답답하다고 하잖아

[권재식] [오후 8:08] 그런 반응은 태음인 열자, 태음인 한자인데 간화가 겹했을때, 소양인
열자.에 나타나는데

이경우 **소음인이 아닌것은 확실한거야**

원래 설사를 잘하는 사람이면 소양인 비신양허 처방으로 가고

원래 설사를 잘 하지 않은 사람이면 태음인이나 소음인으로 가는게 맞을 거야

그리고 **형방지황탕은 내상잡병에 쓰는 약이 아니고 상한의 태음증에 쓰는 약이야...**

그러니까 허리아픈데 아스피린,브루펜시럽을 쓴거지.....

허리아픈데 펜잘이나 낙센같은 약을 쓰야 하는데

나이는 75세. 비만형. **척추관협착증. 좌하각인통.** 유모차에 몸을 지탱해서 걷는 전형적인
시골할머니

병명 : 척추관협착증

1차처방: 건율,연자육,쇄양,오미자, 녹각교,속단,곡기생.진범

3일먹고 남편이 전화옴. --어지러워 쓰러졌다고. 욕업청 먹음
일단 중풍의심되니 검사하자고 다들임.(내심 이석증이 구나 확진했지만,)
검사하고 병원에서 중풍아니고 **이석증이라고 판명남.**
1년이 지나서 한달전에 다시 이 분이 래원했음.
다시 약지어달라고 해서 진맥을 하고 다시 약지어줌
2차처방: **산수유,복령,토사자,복분자,구기자.**
결과: 부기 빠지고, 몸이 가볍고, 통증이 어느정도 완화되었다고함.

슬관절통환자 임상례

나이 57세.비만형. 퇴행성 슬관절염으로 통증심.

1차처방: 방풍,강활,독활,홍모오가피,대맥근,사과락,인동등,선모-매우호전

2차처방: 상동-설사심

1차처방과 같은 처방을 주었는데 설사가 나고 다시 통증심

3차처방:의이인,나복자,마황,백지,석창포,해동피,진범,해백- 많이 호전

3년이 지나서 다시 래원

3차처방을 주었는데 호전은 되나 진전이 더딤

2제를 더주니 호전

55세여. 척추후만. 앉았다 일어날때 좌측골반통심+ 평소 식도염

의이인,유근피,비파엽,백합,사삼,나복자,백질여,감국,백령 1제-호전

골담초는 민간에서 가장 많이 쓰는 약인데 한의사만 안써

육종용은 기본적인 신양허 약인데 아직 체질이 불분명해

일단 내가 골담초를 소양인약으로 많이 써는데,,,확정적이지는 않아

골담초를 한약명은 금작근이야

내가 관절약에 많이 써보는데 효과는 괜찮아

특히 소양인 관절약에 쓸만한 약이 많지가 않아

그리고 접골목이라는 것도 있어.

골담초를 50g을 달여서 15팩을 뽑아.

그리고 하루에 5봉지를 먹어. 3일간.

그런 상태에서 대변,소변,컨디션을 체크하는 거야. 당연히 술은 먹으면 안된다. 일반적인 생활만 하는 거야

지영이하고, 회민이가 먹으면 좋겠다.

그다음에 육종용인데 육종용은 기현이가 먹었으면 해

기현이하고 성훈이.....가 육종용을 먹었으면 해

나는 물론 다 먹어봤어.그런데 육종용이 애매해....확실하지가 않아

만약에 육종용이 정해지면 쓰임새가 정말 많아.

태음인의 쇠양, 소양인의 숙지황처럼 다양하게 쓸수가 있어

육종용이 어느 체질인지 모른다니까

육종용이 확인되면 변비있는 양허증의 협착증의 정증약이 되는 거야

어차피 정력약은 비아그라에 뺏겼으니까 협착증이라고 잡아야지

그리고 마가목도 많이 쓰는데,,,

문제는 이 마가목이 기원이 확실하지가 않아

중국에서 원래 말하는 마가목과 한국에서 말하는 마가목이 서로 안맞아

민간에서 지금 마가목 엄청 먹거든....

그렇다면 한국에서 현재 유통되는 마가목을 기준으로 그게 실제 책에 나오는 효능이 있나 없나를 찾아야 되

그리고 여주

당뇨약으로 많이 먹는 여주.....그리고 석력벽

석벽려. 소나무줄기 타고 올라가는 이것또 당뇨약으로 만이 먹고 있어

70세 할머니 교정중에 늑골에 실금으로 통증극심.

그래서 1차치료-건율6 연자육 , 녹각교4 단삼,홍화2 포황,상황2 를 했더니 대변을 하루 3회 즉시 중단하고,

건율6 녹각교,연자육4 상황,홍화2 를 15첩 30팩- 거의 호전

이경우는 약만 주었어.....한 2,3주간 정말 쫓았다.

왜 그런거같으냐? 단삼 포황 차이밖에없는데

이환자경우 노인이고 위장이 평소 안좋은 환자였어.

그래서 단삼, 포황이 무리를 준거지

이경우가 급병이라도 무조건 실증약을 쓰면 안되는 조건의 환자이지

이런경우 재빨리 약을 바꾸어 주어야 해..안그러면 통증을 못잡아

->늑골골절로 인한 통증극심한 노인환자인데 소화기가 약한 케이스로 단삼포황이 부담스러웠다.

W저처방에 의이인이 빠진 이유는머고

의이인을 쓸 환자가 아니야

의이인과 연자육 ,건율의 차이가 있어

전부다 비기허 약이지만

의이인은 같은 비기허라도 몸에 수분정체가 있어서 즉 수분대사장애이지

그래서 복부가 물살이어야 해

복부가 물살이면서 비기허이면 군약으로 다량쓰지

왜냐하면 의이인의 본성은 이수삼습약이야

그러니까 폐의 가래에도 쓰고, 비만에도 쓰잖아

그런데 저분은 몸이 말랐거든,,,

그래서 뺏거나 아니지. 의이인은 똥똥한 비기허환자의 설사에 쓰는 거지

건율의 포인트는 설사,연변,활변이야

비기허이면서 변이 묽어야해.

산약의 포인트는 마른체형의 비기허환자이지

연자육의 포인트는 심비양허야

심장도 앓으면서 비기허가 같이있는 경우

의이인은 뚱뚱한 비기허환자의 설사에 쓰는 거지

소음인한테 산약 함 줘봐라 어떻게 되는지

속이 거북하고 몸이 처진다

최근에 소음인한테 소양인약을 준적이 있어.

주소증은 아프타성구내염.소양인먹고 3일쯤 지나니까 방귀끼니까 팬티에 대변이 묻어나왔데

바로 약 캔슬시키고 소음인약으로 주었지

오늘와서 하는말이 약이 맛있고 속이 너무 편해요

그러니까 이걸 빨리빨리 바꾸어주어야 하고,,,환자가 뭐라고 하면 빨리 캐치해내야 해....이

사람이 왜 이런 말을 하는지

열증 태음인인데 변비가 있어...그러면 변이 막이면서 불편해

특히 간기울결환자인데 변비야..거기다가 열이 협했어....이러면 산약은 확실히 불편해

더 정확한 산약증은 비신양허증이지

산약하고 가장 친한 친구들이

건율,연자육이지

그럼 열다증이 청간탕계열이것네

산약을 신쪽으로 몰겠다고 생각하면

열다증은 청간탕계열이지...그래서 약이 강해

조심해서 사용해야 해

[권재식] [오후 1:27] 열다한소탕은 외감병에 쓰는 약이라서 이것을 내상병에 쓸려면 약을

조정을 해야해

산약을 신쪽으로 몰려면 호도육이랑 친구를 만들어야 하고,,,

산약을 비쪽으로 몰려면 건율과 친구를 만들어야 해

심장으로 몰려면 연자육과 친구를 만들고 거기다가 인경약으로 호박을 넣는거야

울금은 두가지 쓰임새가 있는데

하나는 간기범위계열,,,,즉 역류성식도염으로 확연히 흉민증이 있거나

심장계열로 심장의 어혈로 흉통이 있어야 해

울금은 정말 정증이라고 생각해야 하지 아무데나 넣으면 잘 안되....

책이 어려운것은 아닌데 이해를 잘 해야 해

그래서 본초를 볼때 배합법을 잘 보면 본초의 성능이 간명하게 나와

말이 난김에 이야기인데.....

이 배합법이 체질문제가 해결이 안되면 답이 안나와

가령,, 연자육+ 토사자하면 유정,활정에 좋다고 하지만

이것보다는 연자육+ 호도육이 더 낫거든 아니면 연자육+ 녹용이 더 낫고 그러면 본초가 깔끔

하게 정리가 되.....잡다하지가 않고

그러니까 당연히 처방의 약갯수가 줄어들수 밖에 없는 구조가 되지....그런데 확실한것은 한

개보다는 두개가 낫고 두개보다는 세개가 낫고, 세개보다는 4개가 나아 그런데 이게 10개

를 넘어가잖아....오히려 떨어져. 그래서 가장 확실한 효과는 내가 생각하기는 4-8개정도가 가장 강력한것 같아

80세 노인

분명히 태음인은 맞는데....약발이 안듣네

연자육10 산약,오미자4 녹각교6 건울,호도육,쇄양,상황2

4제까지는 돈 받았지

현훈이나 기력은 좋아졌는데 소변이 좋다 말았네

이분도 저번에 소음인으로 신허약썼더니 활변으로 하루 2,3번 했던 환자다

소양인약도 안맞고

태음인이 가장 좋았는데 문제는 변증이 안된다

집에있으면 소변 자주 안보고 나가면 자주 보고

야간뇨가 주증이나르

문제는 심허에 따른 심장의 특징적인 증상이 없어

주간에 밖에 나가면 소변빈삭

일단 심허로 한번 밀어보는 수밖에 없다. 다른 게 없어...

거의 같은 계통이제... 군약과 신약을 조금씩 올렸지

닭발 경험에 함 들어봐

64세 마른체형아줌마인데 6월28일 캐나다로 여행잡혀있어

그런데 지난주에 역류성식도염으로 약을 주었다.

중국백출4 반하강제4 진피3 생강,구감초,백두구,대조,계내금,참살2

그런데 이분이 대변소변이 불리해지고 가끔씩 어지럽다해

결정적으로 3일전에 와서 갑자기 허리가 아프데....

캐나다가야 하는데 허리아프다니까 난감....

그래서 급히 약을 바꾸어 주었다.

[권재식] [오후 6:11] 중국백출4 구감초,대조3 백작약구 생강,참살, 계내금,진피2 8첩+ 닭발100g 지금 전화하니까 다 편안해졌데..... 이게 녹각교의 성능과 비슷한것 같아...

이게 원래 아교를 넣어도 좋은데아교가 워낙 비싸잖아...

주의할것은 살 잘찌는 태음인은 먹으면 장난 아니게 살이 찌수 있으니 조심하고

소양인도 마찬가지로. 살 잘 찌다

내가 녹각교를 못 믿는 이유가 힘이 약해.... 그래서 아예 염소를 달이는 거지

정말 보약값을 낸 사람은 녹용을 달이는데...

일반약인데 내가 보약을 주고 싶을때 염소 주는 거야

가능한 소음인약이 많이 들어간 약에 닭발쓰고.

숙지황이나 구기자, 산수유 같은 소양인 약에는 넣지 말고

처방안에서 불필요한 약을 빼다 보니까 다시 넣을 약을 보면 약의 힘이 느껴져야 하잖아...

그런데 약을 쓰다 보면 야 ...~~이약가지고 힘이 나것냐....하는 느낌이 들어....그렇다 다른 초제가지는 계란으로 바위치기이고...

초제는 한계가 있다...

그래서 옛날에는 뱀탕,개고기,토끼탕,,,,이런게 고단백영양물질이 되는 거지
경악전서 폐옹,폐위 파트에 보면 장경악선생이 이런말을 해
흉년이가 기근이 들때나,,,매우 가난해서 끼니가 힘든 사람이 폐옹이 걸렸을때는 실증이라
고 하더라도 반드시 보약을 가해야 하고,,,전적으로 실증약을 쓰면 안된다는 구절이 있다
정말 정확히 본 관점이다....탁월하지....장경악선생이 폐옹걸린환자에게 실증이라고 정력대조
탕같은 약 썼다가 작살이 몇번 났는가봐
얼마나 식겁했었나각혈하고 가래튀고, 천명있고, 맥실한데.....정력자,상백피,황금,,,,주니
까 갑자기 다음날 식욕떨어지고,,,정신훈미해지고,,,식겁하지...
급히 약 바꾸어주었겠지,,,황기,인삼, 백출,당귀,,,,, 그러니까 낫거든
그래서 경악전서 보면 글이 막 살아있어....임상레보고 가슴에 팍팍 와 닿아

보중익기탕의 방해를 보면 진짜 기가 막히다.
보중익기탕의 처방탄생이유와 적응증, 부적응증.....승마,시호를 쓰야 하는 이유와 쓰면 안되
는 이유..... 읽다 보면 숨이 탁탁 막힌다.

아까 말한 승마,시호 문제도 내가 보중익기탕을 보면 늘 의문이었거든
그 문제를 명쾌하게 설명해놓았더라고
보중익기탕의 가장 문제점을 제시하고
자기가 그 문제점을 해결하기 위해 새로운 처방을 창방하잖아.
그게 그 유명한 보음익기전이잖아
보중익기탕이 안맞는 사람에게 쓰는
보중익기탕을 주니까 부작용이 나는 사람이 있거든... 그러니까 자기가 따로 만들었어
그게 바로 보음익기전이야....분명히 중기하함, 노권상인데 보중익기탕이 안맞아... 그래서 보
음익기전을 창방한거나
경악선생은 체질을 알고 있었어
단 이분은 사체질이 아니고 이체질이야....
전충록에 보면 장경악선생의 체질론이 나와
음장지인,양장지인 딱 두개로 나누었어
그래서 초지일관 신방팔진의 처방의 음양으로 구분되어 진행되
다시말하면 이체질론이지
맞다니까 사상의학의 가장 클래식한 버전이지
경악전서는 음양체질의학의 원조야
나중에 상한온병합뵤뵤라
경악전서의 외감병 보면 정리 정말 깔끔하다.
소아환자 식욕부진에 폐경풍열을 쓰는 기준 어떻게 잡고 있냐?
다들 기준이 있겠지만 내기준은 이렇다
현재 감기가 들어있고,,,최소 7일전까지 감기가 들어있었는데,,,현재는 좀 나은상태,,,,그런
데 좀 있으면 또 감기가 들것같은 경우는
그냥 감기약준다....식욕부진으로 왔어도,,,이경우는 무조건 감기약주어야 한다.
이경우에 비기허약주면 약먹는중에 또 전화와서 감기걸렸다다고 전화온다.
그런데 마지막 감기가 보름전에 끝났다...한달전에 끝났다면 일단 비기허약을 주면서 감기약

을 응급용으로 3일분준다.

약먹다가 감기걸리면 응급약먹이라고.

멘트는 약먹다가 감기가 올것 같은데 감기오면 일단 나한테 전화를 주세요라고 멘트를 날린다.

난 객적으로 한약의 맛은 원두커피맛보다는 순해야 한다는 주의인데...

이 유향물약은 내가 달여먹어보니,,,쓰도 쓰도 이렇게 쓸수 가 없어

그래서 결론이 아 유향물약은 외용약이지 내복약으로는 부적합하다라는 결론에 도달해서 내복약으로 안쓴다

이약을 먹고 나아도 못먹겠다고 하겠더라...

굳이 활혈지통약을 쓸려면 맛좋은 약이 많은데 굳이 이걸 쓸필요가 있을까 싶다.

예를 들면,,,목단피,대계, 단삼,홍화,녹각교,호장근,,,,,오공,전갈,,,사과락,인동등,,,

이런약 맛이 상당히 좋거든

나이가 69세 비만 환자

칠성시장에서 수레끌면서 옥수수팔고 있는 여자인데 40년간 옥수수를 팔고 있어.....

통증이 심하여 걷기가 힘들고, 손이 저려서 깨는 뭐 전형적인 족저근막염, 수근완증후군

나이가 이정도 되니까 신허증 당연히 있고,

위장장애는 좀 있겠지

이때는 오장육부약을 줄건지,,,통증약을 줄건지 판단의 기로에 쓴다.

이게 통증약의 관건이야

그래서 나는 일단 통증약을 주었어

인동등6 방풍,사과락3 강활,시호,독활,목단피,대계2 토벌충1 20침

한제먹고 그사람 말로 50% 낫다고 해

그런데 거게 아니고 가끔 체한다면 이때는 통증약으로 밀어야해

그래야 주증이 움직인다니까

이게 분별이 안되면 이런 사람 있잖아 약먹고 속만 편해요 이런데 발바닥은 그대로다

그런데 환자는 속편한것을 원하는게 아니거든

발바닥이 낫는 것을 원하는거든

그런데 약이 정말 정증으로 들어가면 희한한게 통증약을 주었는데 속이 곱따라서 좋아진다....그런데 소화약을 주었는데 이 소화약이 정증이 아니잖아 그러면 소화만 좋아져. .발바닥은 꿈쩍도 안해

또 다른 환자는 갑상선기능항진을 현재 가지고 있는 여자인데 47세 약간 통통한 여자야 주소증이 마찬가지로 족저근막염이야

현재 이여자는 갑상선기능항진약을 먹고 있는데 갑상선증상이 있어

그래서 이경우는 발바닥이 아파도 그냥 갑상선쪽으로 한약을 쓴다

이때 통증은 넣지 않아. 목표를 갑상선으로 보고 치료하는 거지. 그러면 발바닥이 완치가 되 그래서 오장육부약을 줄건지 통증약을 줄건지를 잘 판단하는게 핵심인것 같아.....사실 나도 잘 안되

죽근통,수근완증후군같은 사지말단의 약은

서근활락이 강력히 되어야 해

그런데 기존의 초계로는 사지말단으로 가지를 얹아

목단피,대계같은 약은 기본적으로는 자궁의 어혈약이지

강력하게 멀리 뚫고 가야하는 약이 없어

태음인은 오공,전갈이 있잖아

태양인은 구인이 있잖아

소음인은 그래도 기체어혈약이 많아

그런데 소양인이 없어

독성을 이용하는데 독이 많이 들어가있는 발을 ,머리를 떼면 안되

오공도 그대로 쓴다

전충도 그대로 쓴다

죽력은 어디 약이나..소양인

안그대로 동물성약제가 얼마나 비싼데 그것 떼내면 아까워서 안되...무조건 다 쓴다

인삼도 노두를 떼면 안되 그대로 쓰야해

아깝게 노두를 왜 떼냐

노두와 몸체가 다르다고 하는 말 자체가 웃기는 말이지

그래서 소양인 약에 지통약이 약한데 또 한개가 뭐냐면

이것은 동물성은 아니고 민간에서 많이 쓰는 약인데 골담초라고 들어봤지

그게 한약으로 금작근이야

그것도 상당히 괜찮은 약이야

토벌충은 예전에 우리가 줄준위 작업했는 비증이라는 책이 있잖아

그 논문을 보면 중국에서 상당히 많이 사용하고 있더라고 그래서 내가 구해본거야

마지막으로 두드러기 처방 한개

[권재식] [오후 7:17] 한제먹고 50%호전

28세 남.급성두드러 한달.+ 원인불명:

1차- 백선포,선대4 지부자,백질려,부평초,감국,상엽2 화피3

물론 방편에 청기산 쓰면 되지만

배운게 도독질이라

나이 19세 여자

주증은 안면홍조, 수족냉증이야.

19세여. 덩거나 긴장하면 안면홍조.(더우면 안면홍조심)+ 열음을 좋아해서 늘 입에 물고다

남: 1,2,3차-사삼4 황금,상백피3 천문동,감국,비파엽,백선포,상엽2(이주연-60%호전)

-6개월뒤

4차-상동(비파엽4)(이주연-많이 호전)

-1년뒤에 여름전에 래원

5,6차-금은화,사과략4 지모,현삼3 치자,석고,백화사설초2 지골피2 황연1(이주연-이게

더 좋다)

이경우에 다 찬약이지....

그래도 이약먹고 손발이 따뜻해지고 주증이 훨씬 좋다고 해

[권재식] [오후 7:25] 폐가 상하면 냉한것을 좋아한다고 정확히 나온다고

[권재식] [오후 7:25] 그런데 여기서 분명히 동보에는 뭐라고 나오냐 하면

[권재식] [오후 7:25] 폐가 차면 찬것을 좋아한다고 했거든

[권재식] [오후 7:26] 그런데 이게 바로 교과서적인것 하고 임상적인것에 차이가

나는 이환자를 봐서 살살이 봤는데 아무리 봐고 폐한증이 없어...

아니 다시

아무리 봐도 한증이 아니야

분명히 열증이야

그래서 폐열로 잡은 거야

동보 내경문에 폐상증 첫조문을 봐봐

.형한 냉음즉 상폐...

몸이차고.. 찬것을 먹으면 폐를 상한다..

우리가 상한에서 한사가 들어오면 몸에 열이 나는 타입이 있고

똑같은 한사가 들어가도 몸에 오한이 생기는 타입이 있잖아

마찬가지로 동보에서는 폐한이라고 앓했고 분명히 폐상증이라고 했거든

다시말하면 동보에서도 폐상이라고 했지 폐한,폐열에 대한 언급은 없어

다시 수족냉으로 돌아가면 아까 니가 말한 수족냉에 기본으로 들어가는 약재라는 것이 없다는 거야